

Số: 322 / BV VP MED - HDT & DT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2026



THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Paclitaxel "Ebewe"

Để có thêm lựa chọn thuốc chống ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc chống ung thư Paclitaxel "Ebewe". Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và Cơ chế tác dụng:

- Thành phần: Paclitaxel (6 mg/ml).
- Cơ chế: Thuốc thuộc nhóm chống ung thư (antimicrotubule agent). Paclitaxel thúc đẩy sự lắp ráp các tiểu quản từ các dimer tubulin và ổn định chúng bằng cách ngăn chặn quá trình giải thể, từ đó ức chế sự tái cấu trúc bình thường của mạng lưới vi ống cần thiết cho các chức năng của tế bào ở kỳ trung gian và giai đoạn phân bào.
- Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, trong suốt, không màu đến vàng nhạt

2. Chỉ định và Liều dùng

- Tiền trị liệu (Bắt buộc): *Dexamethasone* (20mg), *Diphenhydramine* (50mg) và Kháng H₂ (*Cimetidine* 300mg/*Ranitidine* 50mg) trước khi truyền *Paclitaxel* từ 30-60 phút để ngừa sốc phản vệ.

Chỉ định	Phác đồ phối hợp / Đơn trị	Liều lượng & Cách dùng
Ung thư buồng trứng	Phối hợp <i>Paclitaxel</i> + <i>Cisplatin</i>	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, sau đó dùng <i>Cisplatin</i> 75mg/m ² . Cách 3 tuần/lần hoặc 135mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 24 giờ, sau đó dùng <i>Cisplatin</i> 75mg/m ² . Cách 3 tuần/lần.
	Đơn trị liệu	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ. Cách 3 tuần/lần.
Ung thư vú	Điều trị hỗ trợ	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, dùng 4 chu kỳ sau phác đồ AC. Cách 3 tuần/lần.
	Điều trị bước 1	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ. Cách 3 tuần/lần.
	Phối hợp <i>Trastuzumab</i>	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, cách 3 tuần (<i>Trastuzumab</i> dùng hàng tuần).

Chỉ định	Phác đồ phối hợp / Đơn trị	Liều lượng & Cách dùng
Ung thư phổi (NSCLC)	Phối hợp Cisplatin	175mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, sau đó dùng Cisplatin 80mg/m ² . Cách 3 tuần/lần.
Sarcôm Kaposi (AIDS)	Đơn trị liệu	135mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ. Cách 2 tuần/lần.

3. Chống chỉ định:

- Bệnh nhân quá mẫn với *Paclitaxel* hoặc dầu thầu dầu Polyoxyl.
- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.
- Số lượng bạch cầu trung tính ban đầu < 1.500/mm³ (< 1.000/mm³ đối với bệnh nhân Sarcôm Kaposi).
- Bệnh nhân suy gan nặng.

4. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

- Cisplatin: Thứ tự truyền: Nên truyền *Paclitaxel* trước *Cisplatin*. Hệ quả: Nếu truyền *Paclitaxel* sau *Cisplatin*, độ thanh thải của *Paclitaxel* giảm khoảng 20%, dẫn đến độc tính tủy xương nặng hơn.
- Các thuốc chuyển hóa qua Enzyme Gan (CYP2C8 và CYP3A4): Thận trọng khi phối hợp *Paclitaxel* với các thuốc ức chế hoặc cảm ứng các enzyme này.
Ketoconazole: Có thể ức chế sự chuyển hóa của *Paclitaxel*, làm tăng nồng độ thuốc trong máu.
- *Cimetidine*, *Ranitidine*, *Dexamethasone*, *Diphenhydramine*: Tờ HDSD ghi nhận việc dùng các thuốc này trong tiền trị liệu không ảnh hưởng đến khả năng liên kết với protein huyết tương của *Paclitaxel*.
- Sarcôm Kaposi (AIDS): *Paclitaxel* có thể dùng đồng thời với các thuốc ức chế Protease, tuy nhiên cần theo dõi chặt chẽ vì các thuốc này (như *Ritonavir*) có thể làm thay đổi chuyển hóa thuốc qua hệ CYP450.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI